家长课堂在脑瘫儿童言语语言康复训练中的应用效果

The Application Effect of Parent Class in Speech and Language Rehabilitation Training for Children with Cerebral Palsy

邬刚燕 谢志蛟 王学敏 黄信萍

WU Gang-yan, XIE Zhi-jiao, WANG Xue-min, HUANG Xin-ping

【摘要】目的 探讨家长课堂在脑瘫儿童言语语言康复训练中的应用效果。**方法** 选取宁波市康复医院 2023 年 1 月~2023 年 6 月收治的符合诊断标准的 2~6 岁伴言语语言障碍的脑瘫患儿 50 例，随机分为对照组和观察组各 25 例。对照组采用常规语言训练，观察组增加家长课堂的培训，并结合课程指导完成家庭训练。两组患儿均每日 1 次，每次 50 min，每周训练 5 天。采用语言发育迟缓评定法（S-S 法)、口腔运动功能量表、最长声时测定、格里菲斯发育评估量表对两组患儿进行语言能力、言语能力及社会生活能力评定。**结果** 治疗前两组评分差异无统计学意义，训练 3 个月后，两组评分均较治疗前提高，且观察组儿童言语语言功能改善有效率显著优于对照组（$P<0.05$）。**结论** 脑瘫儿童进行常规语言训练的同时，对家长开展指导与培训更有利于其言语语言功能的改善，同时对促进脑瘫儿童社会能力的发展具有积极作用，值得临床推广应用。

【关键词】脑性瘫痪；家长课堂；言语；语言；社会生活能力

【Abstract】*Objective* To explore the effect of parents' classroom in speech and language rehabilitation training for children with cerebral palsy. ***Methods*** Fifty children with cerebral palsy aged 2 to 6 years with speech and language disorder who were admitted to our hospital from January 2023 to June 2023 were selected and randomly divided into control group (25 cases) and observation group (25 cases). The control group received routine language training, while the observation group received additional classroom training for parents and completed corresponding family training combined with course guidance. Children in both groups were trained once a day for 50 minutes each time for 5 days a week. ***Results*** There was no statistically significant difference between the

作者单位：宁波市康复医院 宁波 315100
作者简介：邬刚燕 本科 主管治疗师；研究方向：儿童言语语言障碍评估与干预
通讯作者：邬刚燕，E-mail：260964304@qq.com

中国知网 https://www.cnki.net

two groups before treatment. After 3 months of training, the scores of both groups were improved compared with those before treatment, and the improvement efficiency of children's speech and language function in the observation group was significantly better than that in the control group (P<0.05), which was statistically significant. ***Conclusion*** While children with cerebral palsy receive routine language training, guidance and training for parents are more conducive to the improvement of speech and language function of children with cerebral palsy, and have obvious positive effects on the development of social ability of children with cerebral palsy, which is worthy of clinical application.

【Key words】Cerebral palsy; Classroom for parents; Words; Language; Social living ability

脑性瘫痪（Cerebral Palsy，CP）是一组持续存在的中枢性运动和姿势发育障碍、活动受限症候群，这种症候群是由于发育中的胎儿或婴幼儿脑部非进行性损伤所致，常伴有感觉、知觉、认知、交流及行为障碍，以及癫痫和继发性肌肉骨骼问题[1]。临床中约 75%脑性瘫痪儿童存在程度各异的语言障碍[2]，是脑瘫儿童常见的并发症，跟围生期广泛性脑损伤及脑发育缺陷有密切联系，导致大部分言语输入与输出系统产生不同程度的功能障碍[3,4]，主要表现为发音困难、言语清晰度低下、共鸣及韵律异常、语言认知理解和表达发育迟缓等，导致脑瘫儿童在日常活动中表现不佳，不仅阻碍最基本的沟通交流，还对其以后的生活、学习及社会参与造成严重影响。但此时脑瘫儿童的大脑发育功能尚未完成，中枢神经仍具有较强的可塑性。如果在语言发育关键期积极采取补救措施，可最大限度促进脑瘫儿童言语语言的发育。因此，探索提高脑瘫儿童的言语语言功能具有重要意义。

临床应用较多治疗手段对脑瘫儿童进行言语语言干预，但对大多数脑瘫儿童家庭来说，不得不面对长期综合康复治疗所带来的昂贵费用、精力及陪伴等诸多问题[5]，可能被迫中止训练，从而错过最佳干预时间。如果有条件在医疗机构维持训练，也可能由于家长缺乏专业康复知识，无法延续训练，使脑瘫儿童的潜能发挥到最大。或在指导训练过程中存在误区，不但起不到训练效果，反而降低了脑瘫儿童的生活质量[6]。已有研究指出，家长培训对痉挛型脑瘫儿童的粗大运动功能与精细运动功能有改善作用[7]，可提高痉挛性脑瘫儿童的功能独立性[8]，但对脑瘫儿童言语语言应用方面的研究较少。因此，本研究旨在探讨开展家长课堂对促进脑瘫儿童言语语言功能、提高其社会生活能力的重要意义。

1 资料和方法

1.1 一般资料

选取 2023 年 1 月~2023 年 6 月宁波市康复医院收治的符合诊断标准的 2~6

中国知网 https://www.cnki.net

岁伴言语语言障碍的脑瘫患儿 50 例，随机分为试验组和观察组各 25 例。观察组女 12 例，男 13 例，平均年龄 3.03±1.03 岁；对照组女 11 例，男 14 例，平均年龄 3.02±0.93 岁，两组儿童性别、年龄及病因等一般资料比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）。本研究获得宁波市康复医院医学伦理委员会 2023 年伦理审查（科研第 018）。

纳入标准：①符合《中国脑性瘫痪康复指南（2022）》脑性瘫痪诊断标准；②根据中国康复研究中心引进并研制的汉语版儿童语言发育迟缓评定法（Sign-Significate Relations，简称 S-S 法）评定为语言障碍；③年龄在 2~6 周岁，生命体征平稳，神志清楚，训练配合度良好；④患儿家属均签署知情同意书。

排除标准：①癫痫频繁发作，控制未满 1 个月；②严重器质性疾病者（先天性心脏病、肝肾功能不全者）；③辅助检查排除遗传、代谢性疾病；④严重精神发育迟缓、严重智力障碍及听障儿童；⑤由于各种其他原因导致治疗未完成或资料收集不完整；⑥家长不同意且不配合治疗。

两组均采用常规康复训练，包括语言训练、运动疗法、作业疗法、推拿、理疗等项目。语言训练环境：温度适宜，约 25 ℃，10~15 m^2 房间，环境安静，隔音效果好。训练模式：均采用个别化训练+集体课训练模式。研究周期：3 个月。两组干预措施无明显差异，区别在于观察组需开展家长课堂进行系统培训，并在治疗师指导下完成家庭训练内容。

1.2 研究方案

1.2.1 对照组 常规语言训练，如注意力训练、语言理解训练、手势符号理解及应用训练、语言表达训练、口腔感知觉刺激训练、口部运动能力训练、游戏训练等，每次 50 min（含个别化训练+集体课），每周 5 次，训练周期 3 个月。

1.2.2 观察组 在常规语言训练基础上开展家长课堂培训与指导。

集体授课培训：2 次/月，30~45 min/次，包括理论和操作指导两部分。内容包括：①介绍小儿脑瘫相关知识，如脑瘫儿童语言障碍的临床表现、原因、预后及影响等，纠正家长错误认知，让家长意识到家庭康复的重要性；②了解学龄前儿童语言发展规律，如何提供有效语言输入；③掌握儿童的最近发展区，提供恰当的辅助，调动儿童的积极性；④掌握游戏和互动小技巧，激发儿童沟通主动性，在游戏中玩出语言力；⑤如何优化语言环境，调动每个家庭成员，在日常情境中抓住契机进行随机教学；⑥指导家长如何在户外活动时创设条件，增加孩子与他人接触与交流的机会，促进实际交流能力的提升。

中国知网 https://www.cnki.net

共性化技巧指导：1 次/周，20~30 min/次，根据儿童存在共性问题分组指导。①沟通动机不足：选择环境物品设置法。利用儿童有兴趣的物品或玩具，制造困难，引发儿童沟通的动机，同时引导眼神注意和保持视线交流；②手势动作发展落后：手势动作的发展包括初期沟通手势、游戏和日常活动、互动式动作、假扮游戏、模仿成人动作这 5 项。指导家长在日常生活中引导儿童通过手势或身体动作表达“要抱抱”“不要”“给我”等；或利用律动音乐、儿歌、童谣等启发儿童产生相应的手势动作，提升儿童在语言发展初期借助手势动作达到沟通交流的能力；③词汇量掌握不足：遵循横向扩展、纵向提升的原则，如对事物名称可以理解的患儿，可以在单词水平内扩大词汇量，进一步向动词、形容词扩展（横向扩展）；④呼吸支持不足：通过假想性游戏“生日会”中的吹气球、吹蜡烛（设定有效距离）、哼唱生日歌等环节进行练习和强化；⑤口腔运动不协调：面对镜子扮鬼脸，或借助食物的特性（如软硬、粘稠、大小等）引导儿童做下颌、唇、舌的主动运动，加强口腔动作的灵活度和协调性，奠定良好的口腔基础，促进发音动作的精准性；⑥游戏技能不足：根据儿童所处的游戏水平进行游戏设计，如通过拼图、搭积木、堆雪人、用沙筑城堡等进行构建性游戏练习。

个性化训练指导：治疗师根据当天训练内容布置家庭作业，通过微信语音、文字或视频连线方式解答家长疑问，对实施效果进行监督和指导，结合家长的反馈意见和实施情况对训练方案进行优化和调整。

1.3 观察指标

1.3.1 *语言能力评定* 采用中国康复研究中心版 S-S 法进行语言发育评定。临床疗效评定标准：语言功能在同一阶段的横向扩展上以习得新的能力为好转，提高 1 个阶段为有效，提高 2 个阶段为显效，无明显改善或退化为无效。总有效率=（显效+有效）/总例数×100%。

1.3.2 *言语功能评定* 采用口部运动功能评估量表，评价下颌、唇、舌的形态、功能和运动协调性，按功能分 0~4 级，0 级记为 0 分，1 级记为 1 分，2 级记为 2 分，3 级记为 3 分，4 级记为 4 分，总分 132 分，比较两组患儿治疗前后口部运动能力评分的差异。测量最长声时 MPT 数值，评价儿童的呼吸支持能力。

1.3.3 *社会生活能力评定* 选取格里菲斯发育评估量表中文版（Griffiths Development Scales-Chinese Edition，GDS-C）中的个人与社会领域进行评估。该领域评估孩子日常生活的熟练性、独立程度和与其他孩子的交往能力。

1.4 统计学分析

应用 SPSS 19.0 统计学软件进行分析和处理，正态分布的计量资料采用均数±

中国知网 https://www.cnki.net

标准差（$\bar{x}\pm s$）表示，方差齐者组内比较采用配对样本 t 检验，组间比较采用两独立样本 t 检验。计数资料采用频数/百分比（%）表示，等级资料采用秩和检验，$P<0.05$ 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患儿语言能力疗效比较

观察组语言能力改善总有效率为 76%，对照组总有效率为 52%，观察组患儿总有效率显著高于对照组（$P<0.05$），见表 1。

表 1 两组患儿语言能力疗效比较（n=25）[n (%)]

组别	无效	好转	有效	显效	总有效率
对照组	3	9	13	0	52%
观察组	2	4	15	4	76%
Z					-2.118
P					0.034*

注：*$P<0.05$

2.2 两组患儿治疗前后言语功能评分比较

两组患儿治疗前言语功能相比无统计学差异（$P>0.05$）。治疗后，两组患儿 MPT 时长和口腔运动评分均显著高于治疗前（$P<0.05$），且观察组治疗后各项评分均显著高于对照组（$P<0.01$），见表 2。

表 2 两组患儿言语功能治疗前后比较（n=25）

组别	MPT（s）		口腔功能（分）	
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
对照组	1.60±1.25	1.68±1.86[a]	89.32±27.59	93.80±28.37[a]
观察组	1.36±1.11	2.68±1.67[a]	87.52±26.32	97.84±27.75[a]
t	0.714	7.994	0.236	16.528
P	0.504	<0.001	0.814	<0.001

注：a 表示组内比较，$P<0.05$，下同

2.3 两组患儿社会生活能力评分比较

两组患儿治疗前社会生活能力评分比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）。治疗后，两组患儿评分均显著高于治疗前（$P<0.05$），且观察组患儿评分显著高于对照组（$P<0.01$），见表 3。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3　两组患儿社会生活能力治疗前后比较（n=25）（分）

组别	治疗前	治疗后
对照组	26.30±17.10	31.08±19.23[a]
观察组	27.47±14.45	32.46±15.37[a]
t	-0.261	8.083
P	0.795	＜0.001

3　讨论

儿童语言的产生和发展依赖语音听觉系统、发音器官和神经中枢的发育与成熟[9]。脑瘫儿童本身存在神经性损伤，倘若错失最佳干预时期，将对儿童的语言、认知及心理健康产生不良影响。在脑瘫儿童言语语言康复过程中，家长是不可或缺的因素。儿童的语言功能依靠与家人、亲近的照顾者以及社会环境的不断互动来实现[10,11]，其康复效果很大程度上也与家长的配合、努力及坚持相关。脑瘫患儿的常规治疗方法以院内治疗为主，家长难以参与到治疗过程中，且康复训练知识掌握效果较差[12]，对于提高儿童的语言功能及交流能力具有一定的局限性。家庭是孩子熟悉、安全的生活环境，与家人最为亲近，也易解除儿童的心理障碍。另外，从社会心理学角度看，父母有孩子后会自然履行角色义务，对孩子无条件地关爱和呵护[13]。有了亲情的支持和关怀，对于疾病的诊疗和障碍的康复也会产生正向促进作用。

但是诸多脑瘫儿童家庭可能存在以下问题。隔代教养：长辈包办过多，导致儿童缺少生活体验；需求满足过快，减少了主动学习和表达的机会。家长本身教育程度低，文化水平不高，对疾病认知不够。被传统观念误导，认为贵人语迟，孩子迟早会说话，采用观望、等待的态度。脑瘫儿童中多存在口功能问题，家长为方便儿童进食，长期选择泥糊状或软质食物喂养，导致儿童口腔功能缺乏相应锻炼[14]。为减少儿童吵闹，家长过于频繁使用电子产品，单向的语言输入不利于儿童语言表达和社交能力的提高[15]。长期的精神压力和经济负担也可能导致脑瘫儿童家长产生敏感、焦虑、抑郁等心理问题[16]。因此，本研究通过开展家长课堂，对家长进行系统、专业、针对性的培训，提高其对脑瘫疾病的认知，树立康复信心，为脑瘫儿童创造良好的语言学习环境，达到事半功倍的效果。本研究结果发现，两组脑瘫儿童言语语言康复训练后较训练前有所改善，但是观察组的语言能力、发声功能、口腔运动功能分值的提高优于对照组，可见家长课堂的开展更能促进儿童言语语言功能的改善。

中国知网 https://www.cnki.net

另一方面，在家长课堂中，指导父母学会观察孩子的沟通意图，通过改变互动方式、采用有效的沟通策略等，为孩子创造良好的沟通环境，从而促进孩子实际交流能力的发展。经过治疗师的指导，观察到家长与孩子的交流模式发生了积极变化。脑瘫儿童对父母的反应也逐渐增加，可使用更复杂的交流信号提出请求、做出选择、抗议和对自己名字的产生回应，也可使用更多的轮流回合维持与父母的互动行为，表明家长课堂的开展对于脑瘫儿童社会生活能力水平的改善也有明显作用，可提高社会交往及实际交流能力。

综上所述，对脑瘫儿童家长开展家长课堂效果良好，有助于脑瘫儿童言语语言能力及社会性的发展，符合国际功能、残疾和健康分类（International Classification of Functioning, Disability and Health）的理念和框架，值得应用与推广。

参考文献

[1] 李晓捷.实用儿童康复医学(第 2 版)[M].北京:人民卫生出版社, 2016: 244-244.
[2] 叶静燕,戴婷欣,游翠婷.语言治疗对脑瘫儿童语言障碍的临床应用效果研究[J].中国实用医药, 2021, 16(16): 199-201.
[3] 吴海生.实用语言治疗学[M].北京:人民军医出版社, 1995: 249-249.
[4] 王贞,李胜利.不同儿童语言障碍特点及主要相关因素[J].中国康复理论与实践, 2013, 19(6): 536-540.
[5] 覃晓燕.浅谈家庭训练在脑瘫治疗中的作用[J].内蒙古中医药, 2009, 28(24): 118-119.
[6] 安雪梅.影响脑瘫儿童延续性家庭康复治疗依从性的影响因素分析[J].中国药物与临床, 2019, 19(21): 3687-3690.
[7] 张丽华,袁清强,孙颖,等.家长培训对痉挛型脑性瘫痪患儿粗大运动功能的影响[J].黑龙江医药科学, 2015, 38(1): 19-21.
[8] 徐艳,张丽华.家长培训对痉挛型脑性瘫痪儿童功能独立性的影响[J].中国中西医结合儿科, 2015, 7(4): 346-347.
[9] 李晓捷.人体发育学[M].北京:人民卫生出版社, 2008: 91-92.
[10] 康倩倩,杨杰.脑性瘫痪家庭康复培训模式的应用分析[J].医学信息, 2013, 26(1): 150-151.
[11] 罗苏群.我国智力残疾儿童家庭康复研究综述[J].教育导刊(下半月), 2010, (6): 88-91.
[12] 张昊,刘伟,冯蕊.沙盘游戏联合引导式健康教育在小儿脑瘫康复治疗中的应用[J].实用临床医药杂志, 2018, 22(18): 105-107.
[13] 窦文文.父母关爱的心理学探析[J].文教资料, 2009, 22(8): 156-157.
[14] 黄晓煌.结构化系统训练对脑性瘫痪儿童语言障碍的改善效果[J].医学理论与实践, 2015, 28(2): 266-267.
[15] 李秋兰,黄林娟,詹清,等.家庭类型电子产品接触与儿童语言发展相关研究[J].医药界, 2019, (20): 196-197.
[16] 黄宏亮.脑瘫患儿家长心理健康状况的调查分析[J].中国民康医学, 2008, 20(24): 2991-2992.

中国知网 https://www.cnki.net